

CONCURSO PÚBLICO
FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA - HEMOMINAS

EDITAL N.º 01/2024

ASSISTENTE TÉCNICO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA - ATHH - NÍVEL II - GRAU A
TÉCNICO DE INFORMÁTICA

Duração: 4h (quatro horas)
Leia atentamente as instruções abaixo:

01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno, com **60 (sessenta)** questões da prova objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

CONHECIMENTOS BÁSICAS				CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
LÍNGUA PORTUGUESA	SAÚDE PÚBLICA	LEGISLAÇÃO BÁSICA	RACIOCÍNIO LÓGICO	
1 a 10	11 a 20	21 a 30	31 a 40	41 a 60

b) Um cartão de respostas destinado à marcação da alternativa correta.

- 02** Verifique se este material está em ordem e se o seu nome, RG, cargo e número de inscrição conferem com os dados que aparecem no cartão de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
- 03** Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do cartão de respostas, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.
- 04** No cartão de respostas da prova objetiva, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
- Exemplo: 
- 05** Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas **4 (quatro) alternativas** classificadas com as letras (A, B, C e D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
- 06** O candidato poderá entregar seu cartão de respostas, seu caderno de questões e retirar-se da sala de prova somente depois de decorrida **1 (uma) hora** do início da prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência declarando sua desistência do certame, que será lavrado pelo Coordenador do local.
- 07** **Só será permitido ao candidato levar o caderno de questões a partir do momento em que faltar 1 (uma hora) para o horário de término da prova, após entregar o cartão de respostas e assinar a lista de presença.**
- 08** Não será permitida a cópia de gabarito no local de prova. Ao terminar a prova de conhecimentos, o candidato entregará, obrigatoriamente, o seu cartão de respostas. **O candidato que se retirar da sala levando o cartão de respostas estará automaticamente eliminado do certame.**
- 09** Reserve os **30 (trinta)** minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões não serão levados em consideração.
- 10** Os **3 (três)** últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluem a prova ou que termine o seu tempo de duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

LÍNGUA PORTUGUESA

Quando eu deixei de acreditar em mim

Mayara Godoy

Quando foi que essa dúvida se abateu sobre minhas tão sólidas certezas? Quando foi que deixei de acreditar na única pessoa em quem deveria confiar sempre?

Dia desses, me peguei tentando me lembrar quando foi que eu deixei de acreditar em mim mesma.

Eu sempre fui uma pessoa autoconfiante. Pelo menos em alguns aspectos da vida. Desde pequena, eu sempre fui estudiosa, e ia bem na escola. Isso não foi um problema para mim, nem mesmo quando tive de pular um ano no pré-zinho e acabei ficando adiantada, estudando com crianças mais velhas que eu.

Lá pela sexta série, eu já tinha uma clareza de qual carreira gostaria de seguir, e me matriculei na faculdade sem nenhuma dúvida de que aquele seria meu caminho.

Fiz estágios, trabalhos voluntários, me metia em tudo que era evento aleatório, apenas na ânsia de aprender. Tinha sede do mundo, sede de conhecimento, pressa de avançar. Tinha um brilho no olhar que parecia difícil de apagar.

Ao me formar, rapidamente consegui empregos, sempre fui bem recomendada pelos ex-chefes, e sempre fui adiante de cabeça erguida.

Olhando hoje, é muito nítido o quanto eu seguia em frente sem hesitar, o quanto eu tinha certeza de cada passo que dava. Talvez, fosse só imaturidade juvenil, aquela pseudoarrogância típica de quem não viveu muito ainda, aquela ingenuidade que chega a ser bonita. Talvez.

Com o passar dos anos, eu sempre continuei perseguindo o conhecimento, as experiências, o crescimento. Sempre segui estudando, me dedicando, dando o meu melhor.

Mas, em algum momento, isso mudou. Hoje me olho no espelho e não sei mais quem sou. E percebo que não é uma crise com a minha profissão especificamente, é comigo mesma. Aquela autoconfiança, aquela segurança, aquela ousadia, tudo sumiu. Hoje me sinto incapaz, obsoleta, perdida e irrelevante.

Em que momento eu deixei de acreditar em mim? Em que momento meu espírito foi quebrado dessa maneira? Eu sinceramente não sei responder. Não sei se foi um acúmulo de experiências negativas com o passar dos anos, ou se foi alguma situação pontual, mas sinto que algo em mim morreu; o combustível que alimentava esse fogo acabou.

Alguma parte fundamental do meu ser, algum elemento estrutural que me sustentava, ruiu. Como uma coluna de sustentação de um prédio derrubada por engano, sinto que algum dos meus pilares cedeu. Talvez seja o que as pessoas chamam de crise existencial, crise de meia idade, crise dos 30 (e poucos), ou talvez alguma outra ainda não nominada.

Mas, a sensação é a de ter sido completamente dominada pela síndrome da impostora, de ter sucumbido a ela, de ter perdido a vontade de provar que quem duvida de mim está errado. Hoje, eu duvido e faço coro com essas pessoas.

Sei que parece um tanto triste usar este espaço para um desabafo assim, tão pessoal, mas tendo a acreditar que não sou a única. Acredito que mais gente por aí se identifique com esse sentimento – e quem sabe alguém possa me contar como a gente se livra dele?

Fonte: <https://cronicasdecategoria.com/2024/03/05/quando-eu-deixei-de-acreditar-em-mim/>. Acesso em 22/12/2024

1. A leitura atenta do texto permite concluir que a cronista:
 - A) nunca foi muito segura na vida, e isso ficou mais intenso atualmente
 - B) nunca foi uma pessoa inconstante ou indecisa em nenhum momento da vida dela
 - C) sempre teve certeza dos seus objetivos, mas atualmente tem dúvidas sobre algumas de suas capacidades
 - D) sempre teve certeza dos seus objetivos e de sua própria identidade, e isso persiste até os dias de hoje

2. O texto está estruturado em duas grandes partes: uma primeira parte diz respeito a um estado anterior da cronista; a segunda parte diz respeito ao seu estado atual. O trecho que marca a mudança de um estado para o outro é:
 - A) “Dia desses, me peguei tentando me lembrar quando foi que eu deixei de acreditar em mim mesma” (1º parágrafo)
 - B) “Fiz estágios, trabalhos voluntários, me metia em tudo que era evento aleatório, apenas na ânsia de aprender” (4º parágrafo)
 - C) “Mas, em algum momento, isso mudou. Hoje me olho no espelho e não sei mais quem sou.” (8º parágrafo)
 - D) “Alguma parte fundamental do meu ser, algum elemento estrutural que me sustentava, ruiu” (10º parágrafo)

3. O texto anterior é um exemplo de crônica, ou seja, um texto escrito em prosa, normalmente baseado em um acontecimento corriqueiro do dia a dia. Pelas suas características centrais, esse texto é predominantemente:
 - A) narrativo
 - B) descritivo
 - C) expositivo
 - D) argumentativo

4. No título do texto (“Quando eu **deixei** de acreditar em mim”), o verbo em destaque está flexionado no:
 - A) pretérito perfeito do indicativo
 - B) pretérito imperfeito do indicativo
 - C) pretérito imperfeito do subjuntivo
 - D) pretérito mais-que-perfeito do indicativo

5. “Olhando hoje, é muito nítido o quanto eu seguia em frente sem **hesitar**, o quanto eu tinha certeza de cada passo que dava” (6º parágrafo). Em seu contexto de uso, esse verbo destacado significa:
 - A) decidir
 - B) vacilar
 - C) resolver
 - D) ter êxito

6. Na palavra “**pseudo**arrogância”, o elemento em destaque significa algo:
 - A) aparentemente científico
 - B) certamente verdadeiro na essência
 - C) aparentemente real, mas não em essência
 - D) certamente real, tanto na aparência quanto na essência

7. “Lá pela sexta série, eu já tinha uma clareza de qual carreira gostaria de seguir” (3º parágrafo). As palavras destacadas podem ser classificadas, respectivamente, como:

- A) conjunção e substantivo
- B) advérbio e substantivo
- C) conjunção e adjetivo
- D) advérbio e adjetivo

8. “Não sei se foi um acúmulo de experiências negativas com o passar dos anos, ou se foi alguma situação pontual, mas sinto que algo em mim morreu; o combustível que alimentava esse fogo acabou” (9º parágrafo). A oração em destaque é classificada sintaticamente como:

- A) subordinada adjetiva restritiva
- B) subordinada adverbial temporal
- C) coordenada sindética adversativa
- D) subordinada substantiva objetiva direta

9. “Ao me formar, rapidamente consegui empregos, sempre fui bem recomendada pelos ex-chefes, e sempre fui adiante de cabeça erguida” (5º parágrafo). O termo em destaque é sintaticamente classificado como:

- A) sujeito
- B) objeto direto
- C) objeto indireto
- D) agente da passiva

10. “Sempre segui estudando, me dedicando, dando o meu melhor” (7º parágrafo). Nesse trecho, as vírgulas foram empregadas para:

- A) coordenar orações
- B) inserir uma explicação
- C) apresentar o uso de um aposto
- D) indicar uma inversão na ordem dos termos da oração

SAÚDE PÚBLICA

11. Considerando os princípios e as diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH), os aspectos centrais dessa política no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) é:

- A) ser restrita aos atendimentos de alta complexidade, não sendo um princípio norteador das práticas da Atenção Básica e da gestão local
- B) promover a segmentação das práticas de saúde, priorizando a atuação dos profissionais das áreas assistenciais sobre os de gestão, com foco exclusivo no atendimento hospitalar e ambulatorial
- C) ter como diretriz fundamental a integração entre os diferentes profissionais de saúde, o fortalecimento do vínculo com os usuários e a gestão democrática e participativa, visando à construção de um modelo de atenção que considere as singularidades dos sujeitos e territórios
- D) estabelecer que a gestão da saúde no SUS deve ser totalmente descentralizada, com autonomia irrestrita das unidades de saúde locais, sem necessidade de articulação com as esferas federal e estadual

12. De acordo com os princípios da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), a coordenação do cuidado entre os diferentes níveis de atenção à saúde no SUS descreve corretamente a funcionalidade do sistema de referência e contrarreferência da seguinte forma:

- A) o sistema de referência e contrarreferência permite o encaminhamento de pacientes da atenção primária para a atenção terciária, exclusivamente em casos de urgência, sem a necessidade de retorno à unidade de saúde de origem ou a outra unidade de atenção intermediária
- B) o sistema de referência e contrarreferência é exclusivo para pacientes de alta complexidade, funcionando apenas entre hospitais de referência e unidades de saúde terciárias, sem envolver a atenção primária ou secundária
- C) o sistema de referência e contrarreferência visa à descentralização do SUS, permitindo que pacientes possam ser encaminhados diretamente para unidades de urgência sem qualquer avaliação inicial na atenção primária, na qual ocorre o acompanhamento posterior
- D) o sistema de referência e contrarreferência garante o encaminhamento entre os níveis de complexidade, sendo fundamental para assegurar a continuidade do cuidado, com a condição de que, após o atendimento especializado, o paciente deve ser redirecionado à unidade de saúde primária ou a outra unidade de acompanhamento adequado

13. No contexto da participação social nas questões de saúde no Brasil, sobre a legislação que estabelece a participação da sociedade na formulação e controle das políticas de saúde, pode-se afirmar que:

- A) a Lei nº 8.142/1990 estabelece a participação da sociedade na gestão do SUS, mas apenas no nível de municípios, sem previsão para a atuação em nível estadual e federal
- B) a Lei nº 13.979/2020 garante a participação da sociedade nas questões de saúde pública, exclusivamente em situações de emergências sanitárias, como em surtos e pandemias
- C) a Lei nº 8.080/1990 trata da organização do SUS e assegura a participação da sociedade na formulação e controle das políticas públicas de saúde por meio dos Conselhos de Saúde, em todas as esferas do sistema
- D) a Lei nº 9.434/1997 regulamenta a participação da sociedade nas questões de saúde, mas limita-se apenas ao acompanhamento de ações relacionadas ao controle de doenças infectocontagiosas

14. O diagnóstico precoce é um componente crucial das estratégias preventivas. Considerando as fases de prevenção no contexto do SUS e a complexidade das intervenções no processo de cuidado, o nível de prevenção do diagnóstico precoce e a principal finalidade da respectiva abordagem consistem em:

- A) prevenção primária, uma vez que se destina a identificar fatores de risco nas populações, com foco em intervenções educativas e sociais que visem a evitar o aparecimento de doenças, sendo o diagnóstico precoce um reflexo da promoção da saúde
- B) prevenção secundária, com a finalidade de identificar condições de saúde em seus estágios iniciais, através de programas de rastreamento e exames periódicos, para aplicar medidas terapêuticas precoces que podem interromper a progressão de doenças ou diminuir sua severidade, tendo como base a identificação de sinais assintomáticos
- C) prevenção terciária, que ocorre após o diagnóstico de uma condição crônica, sendo o diagnóstico precoce uma ferramenta auxiliar no manejo das complicações e na reabilitação dos pacientes com doenças crônicas não transmissíveis, com foco na melhora da qualidade de vida
- D) prevenção quaternária, que busca evitar intervenções médicas desnecessárias ou excessivas em indivíduos assintomáticos, com ênfase na proteção do paciente contra o uso inadequado de tecnologias, e não no diagnóstico precoce de doenças

15. A vigilância epidemiológica é um dos componentes essenciais do SUS, sendo uma ferramenta estratégica para a promoção da saúde e prevenção de doenças. Seu papel vai além do monitoramento de doenças, englobando a análise contínua dos determinantes sociais da saúde e fatores de risco, visando a orientar políticas públicas de saúde. Sobre sua atuação:

- A) realiza o monitoramento integrado de agravos à saúde, tanto transmissíveis quanto não transmissíveis, e requer a articulação intersetorial com outras políticas públicas, como educação, saneamento e segurança alimentar, além de promover a participação ativa da comunidade na gestão do processo de saúde
- B) identifica e controla surtos e epidemias de doenças transmissíveis, com foco exclusivo em ações de resposta a situações emergenciais, e não inclui o monitoramento de fatores sociais que afetam a saúde, como a desigualdade de acesso a serviços de saúde ou condições de habitação
- C) é uma ação exclusiva da atenção básica, voltada apenas para o acompanhamento de doenças agudas e a notificação de casos de doenças crônicas, sem considerar o envolvimento das comunidades ou a necessidade de integração com outros níveis de atenção e de serviços especializados
- D) foca predominantemente em doenças não transmissíveis, com a coleta de dados e monitoramento realizados de forma isolada pelos centros de saúde, sem integração com outros setores e sem a participação comunitária, limitando-se a estratégias curativas e de controle de risco

16. Para garantir a integralidade do cuidado, os serviços de saúde precisam oferecer não apenas a integração de serviços, mas também uma gestão eficaz e um envolvimento direto da comunidade. A definição mais adequada das linhas de cuidado no SUS, considerando sua articulação entre os níveis de atenção, as políticas intersetoriais e a necessidade de adaptação ao contexto social e territorial é:

- A) uma estratégia que envolve articulação entre os diferentes níveis de atenção, com ênfase no fortalecimento da atenção primária, considerando os determinantes sociais e territoriais da saúde e sendo um processo dinâmico e intersetorial, que inclui a participação da comunidade e a avaliação contínua das necessidades de saúde
- B) concentração de intervenções curativas e emergenciais, com foco exclusivo nas condições de saúde agudas, ignorando o papel da promoção da saúde e das políticas intersetoriais que envolvem áreas como educação, saneamento e segurança alimentar
- C) cuidado que tem como foco exclusivamente os tratamentos especializados e complexos nas unidades de referência de média e de alta complexidade e devem ser direcionadas para condições de saúde de alta incidência, como doenças infecciosas, negligenciando a atenção primária e a promoção de saúde nos territórios mais vulneráveis
- D) uma abordagem centrada na doença, com ênfase na gestão de condições clínicas específicas e uma organização que desconsidera os fatores sociais e culturais das populações, não sendo necessário integrar os diferentes níveis de atenção ou utilizar as redes de apoio comunitário

17. Com base na história e nos marcos do Programa Nacional de Imunizações (PNI) no SUS, é correto afirmar sobre a evolução e o impacto desse programa no Brasil que:

- A) foi criado após a Constituição de 1988, com o objetivo exclusivo de erradicar a febre amarela no Brasil, não se estendendo a outras doenças evitáveis por vacina
- B) foi instituído em 1973, antes da criação do SUS, como uma iniciativa federal independente, sem integração com o sistema de saúde estadual e municipal
- C) foi um dos primeiros programas a ser incorporado ao SUS e tem sido fundamental para a redução de doenças evitáveis por vacina, com campanhas como a de erradicação da poliomielite e a introdução de vacinas contra hepatite B e HPV
- D) sempre foi exclusivamente voltado para a vacinação de crianças, não abrangendo a população adulta ou idosa, com foco em prevenir apenas doenças infantis

18. Joana, 32 anos, vive em um bairro periférico de uma grande cidade. Ela cria sozinha seus dois filhos pequenos e trabalha como caixa em um supermercado. Sua residência, embora pequena, tem o básico para a sobrevivência, mas enfrenta problemas relacionados à segurança, ao saneamento básico deficiente e à falta de transporte público adequado. Além disso, o bairro apresenta altos índices de violência e poucas opções de lazer para a população. Joana não tem plano de saúde e depende exclusivamente do SUS para o atendimento médico, principalmente para a saúde de seus filhos, que frequentemente têm infecções respiratórias devido à poluição e à falta de infraestrutura. Embora tenha um histórico de hipertensão, Joana não realiza acompanhamento médico regular devido à distância da unidade de saúde e ao custo do transporte. Diante do contexto hipotético apresentado, é correto afirmar que:

- A) a saúde de Joana é principalmente determinada por fatores genéticos e hereditários, e as condições ambientais e sociais são secundárias na determinação do estado de saúde
- B) os determinantes sociais de saúde não influenciam diretamente as condições de saúde de indivíduos em contextos urbanos, sendo as intervenções médicas suficientes para o controle de doenças
- C) a definição de saúde no SUS foca apenas nas condições de saúde individual e no tratamento de doenças, não levando em conta os fatores sociais que interferem diretamente nas condições de vida das pessoas
- D) os determinantes sociais de saúde, como a pobreza, o acesso limitado à educação, as condições precárias de moradia e a falta de acesso a transporte adequado, impactam diretamente a saúde da população, sendo fundamentais para o planejamento e a implementação de políticas públicas no SUS

19. No que tange às responsabilidades dos entes federativos no financiamento e na implementação do SUS de acordo com a Lei nº 8.080/1990 e a Lei Complementar nº 141/2012, o papel do Estado na gestão dos recursos financeiros destinados à saúde está presente em:

- A) o Estado é responsável exclusivamente pela gestão de recursos financeiros para a atenção hospitalar e de alta complexidade, não tendo competência para aplicar recursos na atenção básica ou nas políticas de prevenção e promoção da saúde, que são de responsabilidade exclusiva dos municípios
- B) o Estado deve garantir o repasse de recursos financeiros aos municípios para a implementação das ações de saúde, mas não tem a obrigação de destinar um percentual específico de sua receita para o financiamento do SUS, podendo optar por repasses voluntários, de acordo com sua capacidade orçamentária
- C) o Estado tem a responsabilidade de garantir o financiamento da atenção básica, coordenação das ações em nível estadual e repasses financeiros aos municípios, com a obrigação de aplicar um percentual mínimo de sua receita em ações e serviços de saúde, conforme as diretrizes estabelecidas pela Lei Complementar nº 141/201
- D) o Estado é responsável por repassar os recursos financeiros da União para os municípios, mas não tem a obrigação de garantir a aplicação de recursos próprios em saúde, já que essa responsabilidade é restrita ao governo federal, que é o principal financiador do SUS

20. A campanha de erradicação da febre amarela, liderada por Oswaldo Cruz no início do século XX, foi um marco importante na história da saúde pública no Brasil. Um aspecto fundamental dessa campanha é representado por:

- A) Oswaldo Cruz erradicou a febre amarela por meio de um rigoroso controle de mosquitos e vacinação, utilizando o apoio das Forças Armadas e medidas de saneamento básico, especialmente no Rio de Janeiro
- B) a campanha teve como principal estratégia a construção de hospitais especializados em doenças infecciosas, sem a participação da população local, focando apenas no tratamento das pessoas afetadas pela doença
- C) o sucesso da campanha deveu-se apenas à educação em saúde, com palestras e à mobilização popular, sem o uso de tecnologias médicas ou medidas de saneamento
- D) a campanha foi marcada pelo uso exclusivo de medicamentos antivirais para o tratamento da febre amarela, sem a utilização de medidas preventivas como a vacinação

LEGISLAÇÃO BÁSICA

21. De acordo com a Lei nº 869, de 05/07/1952, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Minas Gerais, os cargos que correspondem a uma profissão e aos integrantes de classes são considerados como os de:

- A) carreira
- B) transição
- C) isolamento
- D) comissionamento

22. Em consonância com o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais (Lei nº 13.317, de 24/09/1999 e suas atualizações), a promoção e a proteção da saúde no Estado, observada a legislação pertinente, deve se pautar em determinados princípios, sendo um deles a participação da sociedade em:

- A) conferências sobre saúde, conselhos de saúde e conselho monetário nacional
- B) conferências sobre direitos humanos, conselhos de saúde e movimentos ultramarinos
- C) conferências sobre saúde, conselhos de saúde e movimentos e entidades da sociedade civil
- D) conselhos de saúde, movimentos e entidades da sociedade civil e conselho nacional de educação

23. Uma empresa revelou, em propaganda, sem autorização para tanto, dados pessoais com informações sobre a origem étnica de parte de sua clientela, especialmente de pessoas indígenas, pretos e pardos, com base no cadastro de clientes por ela mantido. Nesse contexto, com base na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, a referida empresa revelou dados pessoais:

- A) digitais
- B) básicos
- C) públicos
- D) sensíveis

24. A Política Nacional de Sangue, Componentes e Hemoderivados, à luz da Lei nº 10.205, de 21 de março de 2001, é regida por princípios e diretrizes, dentre os quais temos a (o):

- A) sigilo sobre a procedência do sangue
- B) universalização do atendimento à população
- C) estímulo à comercialização da coleta do sangue
- D) obrigatoriedade de remuneração ao doador pela doação de sangue

25. A realização de campanhas de divulgação e conscientização para assegurar a Política Nacional de Conscientização e Incentivo à Doação e ao Transplante de Órgãos e Tecidos (Lei nº 14.722, de 14 de agosto de 2023) representa um(a):

- A) acordo
- B) estratégia
- C) alternativa
- D) liberalidade

26. No âmbito da legislação estadual de Minas Gerais, com base no Decreto nº 47.148, de 27 de janeiro de 2017, que dispõe sobre a adoção e a utilização do nome social por parte de pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração pública estadual, as pessoas travestis e transexuais que desejarem utilizar nome social perante a administração pública estadual deverão solicitar ao órgão competente um(a):

- A) inscrição
- B) entrevista
- C) audiência
- D) requerimento

27. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948, representa um marco no âmbito dos direitos humanos ao estabelecer a proteção universal dos direitos humanos. Nessa linha, à luz da referida norma internacional, certo é que todo ser humano tem direito à:

- A) participação no governo do seu país
- B) escolha dos tribunais nacionais competentes
- C) igual remuneração por igual trabalho para certas etnias
- D) plena igualdade, exceto em casos de colapsos econômicos

28. O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos se integra ao sistema global dos direitos humanos. Nessa linha, esse Pacto Internacional assegura a todo ser humano o direito:

- A) à vida, sem restrições
- B) à vida, exceto a pena de morte
- C) à vida, ressalvada situação de pandemia
- D) à vida, exceto em casos de guerra externa ou sua iminência

29. O Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), de 1966, tem como foco os direitos fundamentais que envolvem o campo econômico, social e cultural. Esse Pacto Internacional, à luz dos direitos por ele previstos, objetiva promover:

- A) a política e o acesso digital, garantindo que todos tenham acesso a condições de vida dignas
- B) a segurança e o acesso digital, garantindo que todos tenham acesso a condições de vida dignas
- C) a justiça social e a igualdade, garantindo que todos tenham acesso a condições de vida dignas
- D) a segurança e o acesso ao financiamento de empréstimos, garantindo que todos tenham acesso a condições de vida dignas

30. A Convenção sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, 1966; a Convenção sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, 1979; a Convenção contra a Tortura, 1984; a Convenção sobre os Direitos da Criança, 1989, dentre outros Tratados Internacionais, estão inseridas no Sistema Internacional de Proteção aos Direitos:

- A) digitais
- B) humanos
- C) sensoriais
- D) geracionais

RACIOCÍNIO LÓGICO

31. Em uma avenida reta, situam-se quatro prédios: uma padaria, uma escola, uma farmácia e um hospital, nessa ordem, da esquerda para a direita. Considere as seguintes distâncias:

- Da padaria até a escola, 147 metros.
- Da padaria até a farmácia, 214 metros.
- Da escola até o hospital, 179 metros.

Portanto, uma pessoa que caminhar em linha reta, diretamente da farmácia ao hospital e, em seguida, também em linha reta, caminhar diretamente do hospital à padaria, percorrerá uma distância, em metros, correspondente a:

- A) 408 metros
- B) 418 metros
- C) 428 metros
- D) 438 metros

32. Em uma caixa foram colocados apenas sete livros de Álgebra, nove livros de Aritmética e x livros de Geometria. Escolhendo-se ao acaso um desses livros, a probabilidade de o livro escolhido ser de Geometria é igual a 20%. Portanto, o total de livros contido nessa caixa é igual a:

- A) 10
- B) 15
- C) 20
- D) 25

33. Leia com atenção a informação a seguir:

"Um hectare equivale à área de um quadrado de 100 metros de lado."

Portanto, uma região de 10 hectares corresponde a uma área de x km². O valor de x é:

- A) 0,01
- B) 0,10
- C) 1,00
- D) 10,0

34. O resultado da expressão $\left(\frac{159}{318} + \frac{*}{184}\right)$ será igual a 1 se o símbolo * representar um número natural cuja soma dos algarismos é igual a:

- A) 11
- B) 12
- C) 13
- D) 14

35. A tabela a seguir foi construída de modo que os números escritos na linha 2 estão relacionados com os números escritos na linha 1 de acordo com um padrão.

Linha 1	137	238	363	415	524	689
Linha 2	12	14	13	11	12	x

Segundo esse padrão, o valor de x é:

- A) 22
- B) 23
- C) 24
- D) 25

36. Em um grupo de três pessoas, com idades distintas entre 20 e 30 anos, a mediana das idades equivalia a 23. Com o acréscimo ao grupo de uma quarta pessoa com 35 anos, a mediana das idades passou a ser igual a 26. Antes da entrada da quarta pessoa no grupo, a idade da mais velha, em anos, é:

- A) 26 anos
- B) 27 anos
- C) 28 anos
- D) 29 anos

37. Em um centro de doação de sangue, foram coletadas **N** bolsas de sangue em determinado período. As quantidades de bolsas de sangue dos tipos **O**, **A**, **B** e **AB** foram diretamente proporcionais, respectivamente, a 19, 12, 3 e 1. Se, nesse período, foram coletadas 276 bolsas de sangue do tipo **A**, o valor de **N** é igual a:

- A) 805
- B) 810
- C) 905
- D) 910

38. Conversando em uma cafeteria, Carolina afirmou para Érika: "Se você está tomando café especial, então não precisa colocar açúcar". Uma proposição logicamente equivalente à afirmação de Carolina é:

- A) Se você precisa colocar açúcar, então não está tomando café especial.
- B) Se você não precisa colocar açúcar, então está tomando café especial.
- C) Se você está tomando café especial, então não precisa colocar açúcar.
- D) Se você não está tomando café especial, então não precisa colocar açúcar.

39. Em sua última viagem, João e Maria tiraram um total de **X** fotografias com seus celulares, sendo que 15% delas foram tiradas no celular de Maria, e as 459 restantes, no celular de João. A soma dos algarismos de **X** corresponde a:

- A) 7
- B) 9
- C) 11
- D) 13

40. No pátio de uma pousada, há dois espaços gramados. Um deles é quadrado com lado medindo 10 metros, enquanto o outro tem a forma de um triângulo retângulo com um dos catetos medindo o quádruplo do outro cateto. Se as duas regiões gramadas têm a mesma área, a medida do cateto menor desse triângulo, em metros, é igual a:

- A) $2\sqrt{5}$
- B) $5\sqrt{2}$
- C) $2\sqrt{10}$
- D) $10\sqrt{2}$

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

41. No que se relaciona aos algoritmos, nas estruturas de controle mais utilizadas, a condição de teste pode ser inserida no INÍCIO ou no FINAL da lógica de programação. A permanência e a saída do *loop* ocorrem quando o teste da condição de controle retorna um valor FALSO ou VERDADEIRO. No caso da estrutura de controle conhecida por REPITA... FAÇA... FIM REPITA, para que ocorra a saída da estrutura, a condição de teste é colocada e retorna o valor booleano, respectivamente:

- A) FINAL e FALSO
- B) INÍCIO e FALSO
- C) FINAL e VERDADEIRO
- D) INÍCIO e VERDADEIRO

42. O algoritmo abaixo mostra o emprego de um procedimento com passagens de parâmetros, por valor de ZUM PARA ZPN e por referência de LCL para ZPC.

```
algoritmo "MG"
var
  LCL : caractere
  ZUM, VFV : inteiro
procedimento HEMO(ZPN:inteiro;var ZPC: caractere)
inicio
  ZPN <- 51
  ZPC <- "NORTE"
  VFV <- 0
fimprocedimento
inicio
  ZUM <- 39
  LCL <- "LESTE"
  VFV <- 1
  HEMO(ZUM,LCL)
  se ZUM mod 2 = 1 entao
    LCL <- "OESTE"
  fimse
  escreva(LCL,ZUM,VFV)
finalgoritmo
```

Após a execução desse algoritmo, os valores finais das variáveis LCL, ZUM e VFV são, respectivamente:

- A) LESTE, 39 e 1
- B) LESTE, 51 e 0
- C) OESTE, 39 e 0
- D) OESTE, 51 e 1

43. O algoritmo abaixo mostra o emprego de uma função.

```
algoritmo "HEMOMINAS"
var
  W, X, Y, BH : inteiro
funcao MG2025(AB:inteiro):inteiro
inicio
  se AB < 2 entao
    retorne 1
  senao
    retorne AB * MG2025(AB-1)
fimse
fimfuncao
inicio
  BH <- 60
  para W de 0 ate 1 faca
    se W = 0 entao
      X <- BH MOD 15
      X <- MG2025(X)
    senao
      Y <- BH DIV 20
      Y <- MG2025(Y)
    fimse
  fimpara
  escreval("X = ",X:4," Y = ",Y:4)
fimalgoritmo
```

Após a execução, esse algoritmo irá gerar, respectivamente, os seguintes valores para X e Y:

- A) 0 e 6
- B) 1 e 6
- C) 0 e 24
- D) 1 e 24

44. No que se refere às estruturas de dados, uma pilha HEMOMINAS suporta três operações básicas, definidas a seguir.

- I. PUSH(HEMOMINAS,t) – tem por objetivo inserir um elemento **t** na pilha HEMOMINAS.
- II. POP(HEMOMINAS) – tem por objetivo remover o elemento de topo da pilha HEMOMINAS.
- III. TOP(HEMOMINAS) – tem por objetivo acessar, sem remover, o elemento de topo da pilha HEMOMINAS.

Observe a sequência de operações na tabela abaixo.

(1)	PUSH(HEMOMINAS,A+)
(2)	PUSH(HEMOMINAS,A-)
(3)	PUSH(HEMOMINAS,O+)
(4)	PUSH(HEMOMINAS,B+)
(5)	TOP(HEMOMINAS)
(6)	PUSH(HEMOMINAS,POP(HEMOMINAS))
(7)	PUSH(HEMOMINAS,B-)
(8)	PUSH(HEMOMINAS,TOP(HEMOMINAS))
(9)	POP(HEMOMINAS)
(10)	POP(HEMOMINAS)
(11)	PUSH(HEMOMINAS,O+)

Considerando-se a pilha HEMOMINAS inicialmente vazia e a sequência de operações indicada acima, ao final das operações, o elemento que se encontra no topo da pilha é:

- A) A+
- B) B-
- C) B+
- D) O+

45. Entre os conceitos de BD, um modelo de dados é uma representação visual dos valores e suas relações. O primeiro tipo de modelo de dados é definido está relacionado diretamente a representações abstratas e que permitem análises em alto nível, sem entrar em detalhes de implementação e relacionamentos. Um segundo expõe relações mais claras entre os elementos e alguns atributos relevantes dos valores, mas sem definir uma implementação específica da estrutura, sendo que neste caso, as operações podem ser organizadas em APIs para posterior programação. Finalmente, o terceiro modelo detalha todas as informações dos objetos e seus relacionamentos para a criação do banco de dados na ferramenta escolhida, sendo que, nesse caso, as especificações ocorrem conforme as instruções do manual do sistema, assim como as restrições e as validações de cada campo. Esses três modelos de dados são denominados, respectivamente:

- A) conceitual, lógico e físico
- B) externo, associativo e interno
- C) contextual, seletivo e funcional
- D) estruturado, relacional e hierárquico

46. No contexto dos bancos de dados, uma transação é um programa em execução que forma uma unidade lógica de processamento no BD que deve ser completo e integral, incluindo uma ou mais operações de acesso ao BD, como inserção, exclusão, alterações ou consultas. Quando uma ou mais transações tentam acessar o mesmo recurso para operações de leitura ou gravação, o SGBD precisa ter mecanismos para organizar esses acessos. Um deles garante que uma transação leve o banco de dados de um estado válido para outro estado válido, significando que todas as restrições e as regras de integridade definidas no banco de dados devem ser mantidas após a conclusão de uma transação. Se uma transação violar qualquer regra de integridade, ela será revertida. Esse mecanismo é definido como:

- A) isolamento
- B) atomicidade
- C) redundância
- D) consistência

47. No que se refere aos bancos de dados, enquanto o Modelo Entidade-Relacionamento (MER) é um modelo conceitual, o Diagrama Entidade Relacionamento (DER) é a representação gráfica e principal ferramenta. Na notação original, proposta por Peter Chen, as entidades, os atributos e os relacionamentos são representados por símbolos padronizados. Nesse contexto, para as entidades e os relacionamentos, são utilizados, respectivamente, os símbolos:

- A) triângulos e elipses
- B) retângulos e elipses
- C) triângulos e losangos
- D) retângulos e losangos

48. SQL é a sigla para a linguagem padrão de gerenciamento de dados com bancos de dados baseados no modelo relacional. São grupos de comandos dentro da SQL a "Data Manipulation Language – DML", a "Data Definition Language – DDL", a "Data Query Language – DQL", da "Data Control Language – DCL" e a "Transaction Control Language - TCL". Nesse contexto, dois comandos que pertencem à DML e à DDL são, respectivamente:

- A) DELETE e DROP
- B) INSERT e UPDATE
- C) REVOKE e COMMIT
- D) ROLLBACK e CREATE

49. A tabela da figura faz parte de um banco de dados relacional que suporta a linguagem SQL.

	A	B	C	D
1	CONTROLE			
2	CODIGO	NOME	CARGO	SETOR
3	HEMO_123	CÉLIO	ANALISTA TI	PROJETOS
4	HEMO_297	SELMA	ANALISTA TI	PROJETOS
5	HEMO_123	ELEONORA	TÉCNICO TI	SUPORTE
6	HEMO_297	RAFAEL	TÉCNICO TI	SUPORTE

Para se obter CODIGO e NOME, ordenados por CODIGO, de modo crescente, deve-se empregar o seguinte comando SQL:

A) **SELECT CODIGO, NOME FROM CONTROLE
SORT OF CODIGO ASC;**

B) **SELECT CODIGO, NOME FROM CONTROLE
ORDER BY CODIGO ASC;**

C) **SELECT CODIGO, NOME OVER CONTROLE
SORT OF CODIGO ASC;**

D) **SELECT CODIGO, NOME OVER CONTROLE
ORDER BY CODIGO ASC;**

50. No que se relaciona ao gerenciamento de transações em bancos de dados, um bloqueio pode ocorrer, caracterizado pela existência de um conjunto de processos, no qual se algum deles estiver esperando por um evento que somente um outro processo desse mesmo conjunto poderá fazer acontecer, gerará uma situação de impasse. Para melhor entendimento, pode-se afirmar que essa situação se refere a um termo empregado para traduzir um problema que ocorre quando um grupo de processos competem entre si, que vai depender das características de dois ou mais programas diferentes e dos respectivos processos sendo executados pelos diferentes programas ao mesmo tempo. Nesse contexto, esse termo é conhecido por:

- A) ziplock
- B) interlock
- C) deadlock
- D) hammerlock

51. No que diz respeito ao cabeamento estruturado na implementação de redes de computadores padrão *Fast/Gigabit Ethernet*, a topologia física utiliza um *switch* ou *hub* como concentrador, para o qual convergem os cabos UTP por meio de conexões ponto a ponto individuais aos microcomputadores e *notebooks*. O conector empregado é conhecido pela sigla



RJ-45 e ilustrado na figura, possui 8 (oito) guias, das quais duas são utilizadas na transmissão e outras duas na recepção de dados, por *default*. A escolha entre os padrões de cores para a crimpagem do conector RJ45 depende do contexto da instalação e das normas seguidas, embora ambos os padrões sejam funcionalmente equivalentes em termos de desempenho. A denominação para a topologia, os pares de guias desse conector, utilizados na transmissão/recepção do sinal de dados e as referências para os padrões de cores são, respectivamente:

- A) anel, 3-4/7-8 e T568A/T568B
- B) estrela, 1-2/3-6 e T568A/T568B
- C) anel, 1-2/3-6 e 802.3ac/802.3ax
- D) estrela, 1-4/7-8 e 802.3ac/802.3ax

52. Uma sub-rede de computadores com acesso à internet, está configurada por meio da máscara 255.255.255.224, em conformidade com o esquema de tamanho fixo e cujo endereço de *broadcast* é 217.149.64.223. A representação CIDR para o primeiro endereço IPv4 da faixa atribuída a essa sub-rede é:

- A) 217.149.64.192/27
- B) 217.149.64.192/26
- C) 217.149.64.192/25
- D) 217.149.64.192/24

53. Tendo por foco a arquitetura TCP/IP, dois protocolos atuam na camada de transporte, sendo o primeiro o de controle da transmissão baseado em conexão, sendo mais confiável, mas transferindo dados de forma mais lenta, enquanto o segundo o de datagramas do usuário sem conexão, sendo menos confiável, mas funcionando mais rapidamente. Esses dois protocolos são conhecidos, respectivamente, pelas siglas:

- A) TCP e ARP
- B) FTP e ARP
- C) TCP e UDP
- D) FTP e UDP

54. Com objetivo semelhante ao do Modelo de Referência OSI/ISO, no que diz respeito à divisão da arquitetura em camadas, o TCP/IP consiste na junção dos protocolos TCP e o IP, dois dos mais utilizados. Na troca de informações com os protocolos da camada de aplicação, o TCP utiliza portas conhecidas e padronizadas. Exemplificando, as portas empregadas para o DNS, o SSH e o HTTPS são, respectivamente:

- A) 42, 21 e 135
- B) 53, 22 e 443
- C) 67, 25 e 995
- D) 80, 23 e 161

55. Tendo por referência a arquitetura TCP/IP, existem diversos utilitários para emprego na administração de redes de computadores, baseadas em *Windows* e em *Linux*. Um deles revela as configurações de IP, permitindo obter detalhes sobre endereço IPv4, máscara da sub-rede, *gateway*, DNS e IPv6. Uma vez executado o comando, é possível conferir se o roteador está distribuindo o IP correto e se o DNS atribuído é o correto. Outro utilitário serve para verificar se todos os servidores envolvidos na comunicação entre o computador do usuário e uma determinada página estão operando conforme o esperado. Ao executar esse comando, o *Windows* confere o tempo necessário, em milissegundos, para se conectar a cada um dos computadores intermediários no processo de acesso até a página solicitada. O último rastreado na rota é a página que esse usuário quer visitar. No ambiente *Windows*, esses utilitários são conhecidos, respectivamente, como:

- A) png e tracert
- B) ping e netstat
- C) ipconfig e tracert
- D) ipconfig e netstat

56. A norma 802.3 do IEEE define padrões para o funcionamento, a fabricação, o uso e a manutenção das redes de *ethernet*. Esta norma é um padrão geral para estes tipos de arquitetura de interconexão que conectam dois ou mais aparelhos para que estas se comuniquem entre si. Um dos padrões define a *Ethernet* Óptica, sendo uma extensão do padrão IEEE 802.3, que suporta taxas de até 10 Gbit/s em redes locais, metropolitanas e de longa distância. Para seu funcionamento, utiliza o método de acesso compartilhado aos meios de transmissão CSMA/CD, além de usar o protocolo e o formato de quadro *Ethernet* 802.3 do IEEE, para transmitir dados. Esse padrão é denominado:

- A) IEEE 802.3ac
- B) IEEE 802.3ab
- C) IEEE 802.3af
- D) IEEE 802.3ae

57. No que diz respeito aos códigos maliciosos e aos ataques cibernéticos, há um tipo específico de *spyware*, capaz de capturar e armazenar as teclas digitadas pelo usuário no teclado do computador. Normalmente, sua ativação é condicionada a uma ação prévia do usuário, como o acesso a um site específico de comércio eletrônico ou de *Internet Banking*. Esse *spyware* é conhecido por:

- A) hoax
- B) trojan
- C) rootkit
- D) keylogger

58. O *Linux* é um sistema operacional que emprega um sistema de arquivos, com o objetivo de organizar e facilitar o acesso a todos os arquivos em seus respectivos diretórios. Um diretório é simplesmente um arquivo, distribuído em forma de hierarquia. Existem diversas estruturas de diretórios, com o "*root*" como raiz, ou principal, cujo símbolo usado é a barra invertida - "*/*". No *Linux*, enquanto um é o diretório de programas usados pelo superusuário *root*, para administração e controle do funcionamento do sistema, outro armazena os arquivos de configuração do sistema, específicos da máquina. Um terceiro armazena as bibliotecas compartilhadas no sistema, que podem variar de acordo com a "*distro*" *Linux*, englobando linguagens como *Perl*, *Python*, *C*, entre outras, sendo também neste diretório que estão os módulos do Kernel do sistema operacional. Esses três diretórios são conhecidos respectivamente, como:

- A) /sbin, /etc e /lib
- B) /sbin, /cfg e /bib
- C) /main, /cfg e /lib
- D) /main, /etc e /bib

59. Ao adotar a ISO 27002, as organizações se comprometem com um conjunto de boas práticas, com base em três critérios que constituem os pilares fundamentais dessa norma. O primeiro visa a prevenir o acesso não autorizado às informações, já o segundo assegura que os dados não sejam alterados de maneira inadequada, mantendo sua precisão e confiabilidade, e para finalizar, o terceiro garante que as informações estejam acessíveis sempre que necessário. Esses três pilares são conhecidos, respectivamente, como:

- A) disponibilidade, autenticidade e confidencialidade
- B) confidencialidade, integridade e disponibilidade
- C) autenticidade, confiabilidade e irretratabilidade
- D) confiabilidade, irretratabilidade e autenticidade

60. A norma de segurança NBR-ISO/IEC 27005 tem por objetivo traçar ações para lidar com os riscos de segurança da informação, além de realizar atividades de gerenciamento na área, com aplicação em todas as organizações, independente de tipo, tamanho ou setor. Nesse gerenciamento, a avaliação de riscos envolve três etapas, sendo uma que está associada ao processo de encontrar, reconhecer e descrever riscos, enquanto outra ao processo de compreender os tipos de riscos e determinar seus níveis, mediante critérios preestabelecidos. Essas duas etapas são denominadas, respectivamente:

- A) identificação e análise
- B) validação e monitoramento
- C) modelagem e homologação
- D) prototipagem e implementação

RASCUNHO

PCI Concursos